

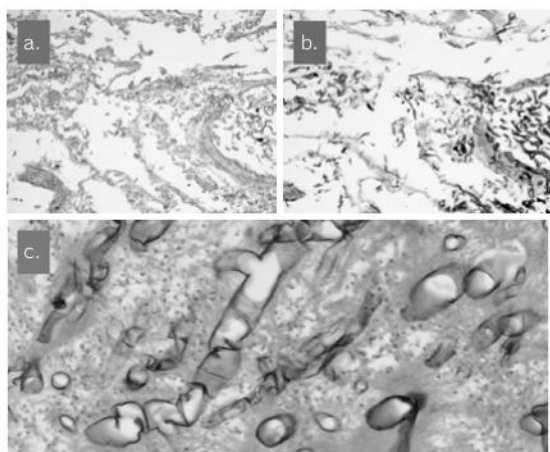


図4 侵襲性肺ムコール症における組織像
a: HE 染色 (×40), b: Grocott 染色 (×40), c: Grocott 染色 (×100)
菌糸は組織内で 15~20 μm と比較的太いが幅は一定せず不規則である。菌体は明瞭な隔壁を有しておらず、ほぼ垂直に分岐する。

以下では肺型ムコール症について概説する。

症候・身体所見

臨床症状は発熱に始まり、咳嗽、血痰、胸痛、呼吸困難を訴え、ときに胸膜摩擦音も聴取される。いずれも非特異的であり、臨床徴候や身体所見のみでの診断は困難である¹⁰⁾。

診断・検査

a 胸部画像所見

胸部 X 線上では多発浸潤影や楔状影を呈する場合が多いが特徴的な所見に乏しい。胸部 CT 上、多発結節影や胸水貯留、ときに“reversed halo sign”を認める¹¹⁾。

b 診断

有効な血清診断はなく、通常 (1, 3) β-D-グルカン は陰性である。これは細胞壁構成成分が主にキトサンであることに由来する。培養による検出率は低く、病変部の病理組織診断が重要となる (図 4)。

治療

治療方針は適切な抗真菌薬投与と病巣部の外科的切除術である。一次治療としての抗真菌薬はポリエン系抗真菌薬の amphotericin B (AMPH-B)、AMPH-B リポソーム製剤 (liposomal amphotericin B: L-AMB) であり、ポリエン系薬無効例、不耐例、ポリエン系薬による治療後の維持療法として、アゾール系の posaconazole (PSCZ), isavuconazole (ISCZ) の投与を考慮する。

Advanced

■reversed halo sign (RHS)

ムコール症ではまれに RHS を生じうるが、組織学的には中心部が凝固壊死巣、辺縁部は肉芽組織である^{A)}。G-CSF 製剤投与時に出現することから、凝固壊死巣に接する部位に好中球が供給されることで肉芽組織が形成され、同部が CT 上での outer rim として描出され则认为られる。すなわち、RHS は免疫再構築の徴候と認められる。

A) Okubo Y, et al: Diagn Pathol 8: 82, 2013

文 献

- 1) Patterson TF, et al: Clin Infect Dis 63: e1, 2016
- 2) 田代将人ほか: 感染症誌 97: 75, 2023
- 3) Tashiro M, et al: Ther Adv Infect Dis 11: 20499361241253751, 2024
- 4) Tissot F, et al: Haematologica 102: 433, 2017
- 5) Tashiro M, et al: Clin Infect Dis 70: 835, 2020
- 6) Rajasingham R, et al: Lancet Infect Dis 17: 873, 2017
- 7) 日本医真菌学会クリプトコックス症の診断・治療ガイドライン作成委員会 (編): 日本医真菌学会クリプトコックス症の診断・治療ガイドライン 2019, 日本医真菌学会, 2019
- 8) Hibbert DS, et al: Mycol Res 111: 509, 2007
- 9) Suzuki Y, et al: Med Mycol J 59: E53, 2018
- 10) Chamilos G, et al: Clin Infect Dis 47: 503, 2008
- 11) Ibrahim AS, et al: Antimicrob Agents Chemother 52: 1556, 2008